Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

SUJET

Examen Blanc n°2 PASS

UE 8 : ICM



Durée de l'épreuve : **45 minutes**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **ne sont pas autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 14 pages numérotées de 1 à 14 et comporte 35 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Question 1
Concernant l'histoire des médicaments laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Herman Boerhaave fait la première description des effets néfastes de l'opium

B. Dans l'occident chrétien, on pense qu'il n'est pas du ressort de l'Homme de soulager la douleur

C. Blaise Pascal est en accord avec ces idées chrétiennes selon lesquelles il faut accepter la douleur telle quelle

D. Velpeau, en 1840 émet l'idée que le chirurgien se doit d'être soucieux de la douleur du patient

E. L'obstétrique accepte l'analgésie au XXe siècle alors que la chirurgie l'accepte au XIXe siècle

Question 2
Concernant l'histoire des médicaments laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. R. Stockmann souligne la puissance analgésique du diacétyl-mophine en 1887

B. Concernant les antagonistes des opiacés, la N-allylnormorphine, opiacé de synthèse, est synthétisée par Pohl en 1915

C. Les récepteurs aux opioïdes sont découverts en 1873 par Candace Pert, Salomon H. Snyder, Eric Simon, Avram Goldstein, Lars Terenius

D. Les quatres premiers médicaments vendus par Bayer sont l'aspirine, l'héroïne, le lycetol et enfin le salophen

E. La loi du 12 juillet 1916 pour prohiber l'usage de la morphine et de la cocaïne sera critiquée notamment par Antonin Artaud

Question 3
Concernant les cibles et mécanismes d'action des médicaments, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Les benzodiazépines sont actives uniquement en présence de GABA

B. Les cyclo-oxygénases permettent de produire des prostaglandines qui auront un effet inflammatoire

C. La DPP-4 est une enzyme dont l'inhibition diminue les concentrations de GLP-1

D. La noradrénaline possède une action antihypertensive

E. La fluoxétine est un inhibiteur sélectif de la recapture de la dopamine

Question 4
Concernant les cibles et mécanismes d'action des médicaments, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le salbutamol est un antagoniste permettant une dilatation bronchique

B. La fixation de GABA sur son récepteur GABA-B permet de diminuer l'excitabilité neuronale

C. Un même neuromédiateur peut agir sur un RCPG et un récepteur canal

D. Les récepteurs nucléaires sont situés en intracellulaire

E. La liaison spécifique correspond à la liaison d'un ligand à son récepteur spécifique

Question 5
Concernant la conception du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le pH de l'estomac privilégie la formation des formes non ionisées

B. L'acétylation de la COX1 peut favoriser la survenue d'hémorragies

C. L'acétylation de la COX1 entraîne une inhibition de la synthèse des prostaglandines proinflammatoires

D. Le site actif de la COX2 est dépourvu de l'isoleucine

E. Les coxibs sont sélectifs des COX2

Question 6
Concernant la conception du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. En cas d'induction des CYP450, une dose standard de paracétamol peut devenir hépatotoxique

B. La FAAH est indispensable à l'effet antalgique du paracétamol

C. Le paracétamol active directement les récepteurs cannabinoïdes CB1

D. Une lésion des voies sérotoninergiques descendantes supprime l'effet nociceptif des agonistes des récepteurs CB1

E. Les cycles B, D et E sont essentiels à l'action analgésique de la morphine

Question 7
Concernant l'insuline, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. L'insuline est une hormone hypoglycémiante, elle diminue le stockage hépatique du glucose

B. La sensibilité de l'insuline à la chaleur et au froid rend l'administration parentérale impossible

C. Aujourd'hui, l'insuline destinée au traitement du diabète est uniquement produite par génie génétique

D. Les insulines à action rapide miment la production physiologique basale d'insuline

E. L'association avec la protamine diminue la solubilité de l'insuline à pH physiologique

Question 8
Concernant les antidiabétiques oraux, laquelle (lesquelles) des propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Les glinides exercent leurs effets hypoglycémiants en diminuant la réabsorption du glucose au niveau rénal

B. La metformine est un biguanide, traitement de première intention pour le diabète de type I

C. Les sulfamides ont le même mécanisme d'action que les gliflozines

D. Le mécanisme d'action des incrétinomimétiques consiste à inhiber la DPP-4 ou à mimer le GLP-1

E. Le peptide naturel exendine-4, isolé du venin du monstre de Gila, a donné lieu aux inhibiteurs de DPP-4

Question 9
Concernant la production du médicament, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. La lixiviation est un procédé de dissolution simple consistant à faire passer un solvant porté à ébullition à travers des matières premières solides

B. La stérilisation permet l'élimination de micro-organismes vivants

C. Les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) sont garanties par les pharmaciens

D. Pour la stérilisation de produits thermosensibles, on peut utiliser une autoclave à 121°pendant 15 minutes

E. L'insuline NPH dans sa forme injectable se fait par voie intraveineuse (IV)

Question 10
Concernant les formes galéniques, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. La phénylalanine est un exemple d'excipient à effet notoire

B. Les patchs sont utilisés pour la voie cutanée

C. La voie parentérale nécessite l'utilisation d'instruments stériles

D. Le risque de contamination fait partie des inconvénients de la voie parentérale

E. Les réactions de polymérisation de l'insuline se font à pH acide

Question 11
Concernant la pharmacocinétique, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. La filtration glomérulaire est un phénomène actif

B. Les mono-amines oxygénases sont un exemple d'enzyme de type I

C. La sécrétion tubulaire du plasma vers l'urine tubulaire est un mécanisme saturable et un phénomène actif

D. La substance active (SA) peut exister sous une forme liée aux leucocytes

E. La pharmacodynamie décrit l'effet de l'organisme sur la SA

Question 12
Concernant la pharmacocinétique, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. Les paramètres pharmacocinétiques secondaires sont calculés à partir des paramètres primaires, ces derniers englobent : la hauteur, l'aire sous la courbe et la pente

B. Il faut environ 5t(½) pour que le processus pharmacocinétique soit complet

C. La demi-vie d'élimination de la morphine est de l'ordre de quelques heures

D. La voie orale est une voie d'administration moins utilisée que la voie intra veineuse

E. Il y a des variations importantes du pH le long du tractus digestif allant d'un pH acide de 8 dans l'estomac à un pH plutôt basique de 1,5 à partir du jéjunum

Question 13
Concernant la pharmacocinétique, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Quand un médicament est administré par doses répétées, si l'intervalle de temps entre les prises est inférieur à $6t_{1/2}$ il s'accumule jusqu'à un niveau d'équilibre

B. La plupart du temps, les paramètres biologiques de pharmacocinétiques suivent une loi de distribution normale

C. Le sujet âgé en bonne santé est considéré comme étant en insuffisance rénale et hépatique

D. Pour un même traitement, les personnes âgées reçoivent souvent une dose plus faible qu'un sujet plus jeune

E. Le "grey baby syndrome" est lié à l'administration de dose trop élevées de chloramphénicol chez le nouveau né

Question 14
Concernant la pharmacocinétique, laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Il faut diminuer la dose d'un traitement pour un sujet en insuffisance hépatique

B. L'érythromycine a pour conséquence de diminuer rapidement le métabolisme des autres substances actives par inhibition enzymatique après son administration

C. L'alcool entraîne une diminution de l'effet thérapeutique des prodrogues

D. Les sujets métaboliseurs rapides présentent un risque accru de surdosage

E. Il existe d'importantes variations ethniques dans la fréquence des différents types de métaboliseurs de la rifampicine

Question 15
Concernant le développement du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Pour obtenir un médicament, environ 10 000 molécules sont identifiées et testées

B. La dose létale 50 (DL 50) correspond à la dose tuant 50% des animaux à 48h après l'injection

C. La détermination du Non Observed Adverse Effect Level (NOAEL) impose une durée de suivi du traitement d'au moins 3 ans sur un modèle animal

D. La caractérisation du profil toxicologique d'un médicament comprend l'étude de la reprotoxicité et de la cancérogénèse

E. L'établissement des propriétés pharmacodynamiques d'un médicament nécessite de l'expérimenter sur au moins 3 espèces animales

Question 16
Concernant les études de reprotoxicité, de mutagenèse et de cancérogenèse, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. Les études de tératogenèse comportent 3 types d'études

B. Les mutations des cellules somatiques présentent un risque héréditaire pour la descendance tandis que celle des cellules germinales présentent un risque cancérogène pour l'individu

C. Pour les études de cancérogenèse, il faut au minimum 50 animaux par sexe et par dose

D. La dose la plus forte administrée pour les études de cancérogenèse est proche de la dose maximale tolérée

E. Le thalidomide est un exemple de médicament qui a eu des conséquences tératogènes

Question 17
Concernant le développement du médicament, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Il est obligatoire d'obtenir l'accord de l'ANSM avant tout essai thérapeutique

B. La phase I des essais cliniques peut être réalisée sur des patients malades

C. Les études de non-infériorité permettent de comparer le traitement en développement avec un placebo

D. La phase IV des essais cliniques permet d'étendre les indications

E. Le plan de gestion des risques permet de suivre l'utilisation réelle du médicament

Question 18
Concernant l'autorisation de mise sur le marché, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Dans l'Union européenne, l'AMM est demandée à la Commission européenne

B. La procédure européenne centralisée est obligatoire pour un médicament générique indiqué dans le traitement des maladies auto-immunes

C. La procédure décentralisée est pilotée par l'État référent qui a octroyé l'AMM existante

D. Pour la procédure de reconnaissance mutuelle, les AMM sont délivrées par les autorités compétentes des États membres concernés

E. La Commission spécifique de réévaluation du rapport bénéfice risque peut aboutir à la modification de la forme galénique du médicament

Question 19
Concernant les autorisations de mise sur le marché, lequel (lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. L'autorisation d'accès compassionnel (AAC) peut être octroyée par la Haute Autorité de santé

B. L'autorisation d'accès précoce (AAP) peut être octroyée par l'ANSM

C. Les médicaments orphelins sont des traitements indiqués en cas de maladies rares

D. Un médicament générique doit notamment avoir la même forme pharmaceutique que le princeps

E. Pour les médicaments homéopathiques, l'AMM n'est pas toujours obligatoire

Question 20
Concernant les procédures spécifiques d'autorisation de mise sur le marché, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Dans les procédures dérogatoires nous avons les accès précoces et compassionnels ainsi que les AMM aménagées

B. Cette même autorisation d'accès compassionnelle (AAC) est délivrée par l'ANSM lorsqu'un laboratoire souhaite commercialiser un médicament

C. Depuis 2007 les industries doivent déposer un PIP (plan d'information pédiatrique) auprès de la PDCO (comité pédiatrique de l'EMA)

D. Pour les médicaments génériques, deux médicaments sont bio-équivalents si les bornes [min, max] du ratio générique sur princeps calculées des valeurs de l'AUC et de la Cmax sont incluses dans l'intervalle [80 % et 125 %]

E. Toutes les réponses sont fausses

Question 21
Concernant le prix et le remboursement des médicaments, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Les questions relatives au prix et au remboursement relèvent de la compétence de l'Union européenne

B. Le ministère de la Santé donne son avis sur l'inscription ou non du médicament sur la liste des spécialités remboursables

C. Le taux de remboursement est décidé après évaluation du service médical rendu (SMR)

D. La Commission de Transparence fait partie de la Haute Autorité de Santé

E. Les États européens doivent respecter un délai réglementaire de 180 jours pour fixer le taux de remboursement et le prix.

Question 22
Concernant le prix et le remboursement des médicaments, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. La détermination du SMR d'un médicament se base sur six questions

B. La gravité de la maladie fait partie des questions pour le SMR

C. Un traitement symptomatique évite une maladie

D. La nature d'un traitement peut être symptomatique, organique, préventif, diagnostique, ou curatif

E. Les recommandations de prise en charge de la maladie par la HAS et les sociétés savantes sont à prendre en compte dans le SMR

Question 23
Concernant la fixation du prix des médicaments, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) ?

A. Une ASMR de niveau IV marque une amélioration importante

B. Pour évaluer l'ASMR, il faut des essais thérapeutiques comparatifs à des médicaments déjà commercialisés dans la même indication

C. La fixation du prix tient compte du prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation

D. La fixation du prix s'inscrit dans un cadre conventionnel général appelé "accord cadre" conclu entre le CEPS et le représentant de l'industrie pharmaceutique

E. Les médicaments revendiquant une ASMR élevée sont concernés par une évaluation médico-économique

Question 24
Concernant les règles de prescription, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Les prescriptions des pédicures podologues sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie depuis 2005

B. Les sages-femmes et infirmiers ont les mêmes droits de prescription en matière de vaccins

C. Les infirmiers peuvent prescrire des traitements de substitution aux opiacés

D. Un chirurgien dentiste peut prescrire des médicaments classés comme stupéfiants

E. Les pharmaciens d'officine ou de PUI peuvent prescrire des vaccins vivants atténués

Question 25
Concernant les règles de prescription, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. Les deux destinataires de l'ordonnance sont les pharmaciens et les organismes de sécurité sociale

B. La forme galénique et la posologie doivent être inscrites sur l'ordonnance

C. L'ordonnance sécurisée de stupéfiants n'est pas délivrée dans sa totalité si elle n'est pas présentée aux pharmaciens dans les 3 jours suivant sa date d'établissement

D. L'ordonnance bizone est utilisée pour les patients ayant une affection longue durée (ALD)

E. Le prescripteur peut utiliser la mention "Non substituable : contre-indication formelle" s'il n'existe pas de générique avec la forme galénique adaptée à l'enfant

Question 26
Parmi les propositions suivantes concernant la pharmacovigilance, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Un abus désigne un usage excessif intentionnel, persistant ou sporadique, de médicaments, accompagné de réactions physiques ou psychologiques nocives

B. La iatrogénie médicamenteuse désigne les évènements indésirables liés à l'intervention d'un professionnel de santé et ayant des conséquences néfastes sur la santé d'un patient

C. Les effets indésirables de type C désignent les effets cutanés d'un traitement

D. L'anémie hémolytique est un effet indésirable de type B de mécanisme immuno-allergique

E. La ré-administration est contre indiquée pour les effets indésirables de type B et C

Question 27
Concernant la pharmacovigilance, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. La probabilité de survenue des effets indésirables reste la même tout au long de la vie du médicament

B. Le 3ème trimestre de la grossesse est une période propice au risque de tératogenèse

C. Un effet indésirable inattendu peut être détecté lors des essais cliniques

D. Il existe un risque de thrombose chez les patients hypersensibles à la Warfarine

E. La polymédication est un facteur de risque lié au médicament

Question 28
Concernant la pharmacovigilance, laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. Les produits sanguins labiles sont des médicaments dont les effets indésirables sont pris en charge par l'hémovigilance

B. L'addictovigilance concerne toute substance ayant un effet psychoactif comme par exemple le tabac

C. Un effet indésirable est considéré comme très rare lorsque sa fréquence est inférieure à 0,01%

D. La pharmacovigilance fonctionne en trois étapes : le signalement des effets indésirables puis l'enregistrement, l'analyse et la transmission par les 31 CRPV de ces déclarations relatives aux effets indésirables et enfin l'analyse, la décision, l'information quant à ces effets indésirables par l'ANSM et l'EMA

E. Les professionnels de santé (pharmaciens, médecins, sages-femmes et dentistes) ainsi que les entreprises du médicament sont dans l'obligation de signaler tout effet indésirable suspecté

Question 29
Concernant le bon usage du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. L'évaluation de la bonne tolérance du traitement est du ressort de l'infirmier

B. L'erreur médicamenteuse est l'omission ou la réalisation non intentionnelle d'un acte impliquant un médicament durant le processus de soins

C. Une erreur médicamenteuse latente est interceptée avant administration du produit au patient

D. L'erreur de forme galénique est une cause d'erreur médicamenteuse

E. L'erreur de posologie ou de concentration est une cause d'erreur médicamenteuse

Question 30
Concernant le bon usage du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes.

A. L'ANSM, l'HAS et l'EMA sont des sources d'informations contrôlée

B. Le RCP comprend la posologie, la pharmacocinétique et le prix de production du médicament

C. L'observance est l'adéquation entre le comportement du patient et les recommandations de son médecin concernant sa prise en charge thérapeutique

D. Pour la promotion du bon usage du médicament, il existe 2 niveaux d'intervention à l'échelle du patient : l'éducation pour la santé et l'éducation du patient

E. Le médecin prescrit à bon escient le médicament, suit le patient et s'assure de l'administration des médicaments

Question 31
Concernant les aspects sociétaux et économiques du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes.

A. En 2019, la consommation de soins et biens médicaux équivaut à 37 milliards d'euros, dont 33 milliards en ville et 4 à l'hôpital

B. La France est le quatrième pays où les ménages financent le moins la dépense courante de santé au sens international

C. L'arrêt du traitement par statines augmente le risque d'infarctus

D. Les antihypertenseurs prescrits à prendre le matin sont plus susceptibles d'être pris par rapport à ceux prescrits à prendre le soir

E. La mucoviscidose touche 20 personnes sur 100 000

Question 32
Concernant les aspects sociétaux et économiques du médicament, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes.

A. Après la campagne de 2010, la céphalosporine a été moins prescrite à l'hôpital

B. En 1986, les premières trithérapies sont disponibles pour inhiber l'efficacité du virus VIH

C. En 2013, seulement 37 % de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH avaient accès aux antirétroviraux

D. Tous les médicaments entraînant des effets indésirables graves sont retirés du marché

E. Le traitement d'homéopathie peut être remboursé

Question 33
Concernant la pharmacoéconomie laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Plus le prix est faible, plus la quantité demandée sera grande

B. L'offre est la relation entre le prix d'un bien et la quantité que les consommateurs sont disposés à offrir

C. On parle d'élasticité forte lorsque la demande est peu sensible à une variation de prix

D. Les 5 règles de la concurrence pure et parfaite sont l'atomicité, la bienveillance, le fait qu'il n'y ait pas de barrière, l'homogénéité du produit et la mobilité des facteurs de production

E. La valeur du médicament n'est pas connue au moment de l'achat

Question 34
Concernant la pharmacoéconomie laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Le principe général dans une économie de marché est que les prix doivent refléter la valeur et non les coûts

B. La valeur d'un médicament est mesurée par sa capacité à prolonger la vie ou améliorer la qualité de vie en répondant à un besoin non satisfait

C. Le prix est théoriquement d'autant plus élevé que le médicament est efficace

D. La France est le 2ème marché pharmaceutique européen derrière l'Allemagne

E. La méthode de référence interne consiste en l'application des prix du médicament concerné pratiqués dans un groupe de pays comparateurs

Question 35
Concernant la pharmacoéconomie laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exactes ?

A. Le résultat de l'évaluation économique se présente sous la forme d'un ratio appelé ratio différentiel coût-résultat

B. L'efficience consiste à se demander si les coûts engagés sont justifiés par les gains en santé obtenus

C. Le ratio différentiel coût-efficacité correspond au rapport de la différence d'efficacité entre deux traitements et de la différence de coût associée

D. L'interprétation des résultats relève d'une décision technique

E. Une intervention est dominante si elle est moins chère et plus efficace qu'une autre

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

AYADA-ANGOULVANT Amina (L.AS 3 Sciences Psychologiques), Alicia ZHANG (L.AS 2 Biomédicales), Jana CHIKHAOUI (L.AS 2 SIAS), Mayena LAHBIB (L.AS 2 MedPhy), Mai-Lan Tandavarayen (L1 Biomed), Ombeline D'ANTERROCHES (LAS2 Biomed), Benjamin PLASSART (RM SHS EB 2025-2026, DFGSM2), Mehdi Serisser (DFGSM2), Mihran FARRUGIA (DFGSO2), Hela SEOUDI MOHAMED (L.AS 3 Arabe maghrébin), Léa NDOUR (DFGSM2)

Relecteurs :

Mayena LAHBIB (L.AS 2 MedPhy), Mai-Lan Tandavarayen (L1 Biomed), Ombeline D'ANTERROCHES (LAS2 Biomed), Steven SAING (DFGSM2, MA), Mihran FARRUGIA (DFGSO2), Léa NDOUR (DFGSM2), Benjamin PLASSART (RM SHS EB 2025-2026, DFGSM2), Anaé BASSIÉ (DFGSM2, MA 25-26), Lina RAHMI (Master 1 Sciences du médicament et des produits de santé)

Convertisseurs LaTeX :

Mahaut MAROUVIN (DFGSM2)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2) et Souad BENABDI (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Dafalgang**

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Mahaut MAROUVIN (DFGSM2)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :
Titre du cours
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe
Question

Utilise la loupe 🔍
(en haut à droite)

Questions exos/annales :
Qxx (ex : Q03 et non Q3)
Énoncé
Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP